

Résumé : Les Strabismes Concomitants

****Dr Camilia Chafter****

1. Introduction et objectifs

Les strabismes concomitants représentent une part importante de l'activité orthoptique et nécessitent une approche clinique rigoureuse ainsi qu'une prise en charge précoce.

****Objectifs du cours : ****

- Définir précisément un strabisme concomitant.
- Reconnaître les différentes formes cliniques.
- Réaliser un examen orthoptique complet et interpréter ses résultats.
- Participer à la prise en charge thérapeutique adaptée à chaque situation.

2. Rappel : Concomitant vs Incomitant

| Caractéristique | Strabisme concomitant | Strabisme incomitant |

|---|---|---|

| Angle de déviation | ****Constant**** quelle que soit la direction | ****Variable**** selon la direction du regard |

| Motilité oculaire | ****Conservée**** | Limitation ou restriction musculaire |

| Mécanisme principal | Déséquilibre du contrôle binoculaire | Paralysie ou restriction musculaire |

3. Définition

Un strabisme concomitant est une déviation permanente ou intermittente des axes visuels, dans laquelle :

- L'angle de déviation reste ****constant**** dans toutes les directions du regard.
- La motilité oculaire est ****conservée**** (pas de limitation des mouvements).
- Il traduit principalement un ****déséquilibre du contrôle binoculaire****, et non une atteinte musculaire ou neurologique.

4. Physiopathologie

La physiopathologie repose sur une interaction complexe entre facteurs moteurs et sensoriels :

- 1. ****Défaut de fusion binoculaire**** → incapacité à maintenir l'alignement des yeux.
- 2. ****Anomalies de réfraction**** (notamment l'hypermétropie) → hyperactivité accommodative → convergence excessive.
- 3. ****Facteurs génétiques et développementaux**** → peuvent intervenir dans l'apparition du trouble.

5. Conséquences sensorielles

Chez l'enfant, la diplopie est rarement ressentie car le cerveau met en place des mécanismes d'adaptation :

| Mécanisme | Description |

|---|---|

| ****Suppression**** | Le cerveau supprime l'image de l'œil dévié pour éviter la confusion visuelle |

| ****Amblyopie**** | Conséquence à long terme d'une suppression prolongée (baisse de l'AV de l'œil non utilisé) |

| ****Correspondance Rétinienne Anormale (CRA)**** | Modification de la perception de l'espace visuel |

6. Classification

Les strabismes concomitants se classent selon plusieurs critères :

| Critère | Types |

|---|---|

| ****Direction de la déviation**** | Éstropie (vers l'intérieur) / Exotropie (vers l'extérieur) |

| ****Mode d'apparition**** | Constant / Intermittent |

| ****Âge de survenue**** | Infantile (précoce) / Acquis (tardif) |

7. Rôle de l'orthoptiste

L'orthoptiste joue un rôle **central** à toutes les étapes :

- Dépistage et suivi après traitement.
- Mesures précises de la déviation.
- Évaluation des fonctions sensorielles.
- Mise en place de la rééducation visant à améliorer la vision binoculaire.

8. Examen orthoptique

8.1 Interrogatoire

- Âge d'apparition du strabisme et mode d'installation.
- Caractère permanent ou intermittent.
- Présence de diplopie ou de signes fonctionnels associés.
- Antécédents familiaux de strabisme ou d'amblyopie.

8.2 Inspection

- Position de la tête (torticolis compensateur éventuel).
- Qualité de la fixation.
- Présence d'un clignement excessif ou fermeture d'un œil.
- Dominance oculaire.

8.3 Cover test

Examen clinique fondamental permettant de mettre en évidence une déviation manifeste ou latente :

- **Principe** : occlusion d'un œil pendant que l'autre fixe une cible → observation du mouvement de refixation à la levée de l'occlusion.
- **Cover test simple** : révèle la tropie (strabisme manifeste).
- **Cover test alterné** : dissocie les yeux et mesure l'angle **total** de la déviation.

8.4 Mesure de l'angle

- Prismes placés devant l'œil pour neutraliser le mouvement de refixation.
- Mesure de **loin** et de **près** pour détecter des variations.
- Le **synoptophore** permet d'affiner la mesure et d'analyser les capacités de fusion.

8.5 Étude sensorielle

- Évaluation de la stéréoscopie (tests spécifiques).
- Permet de déterminer le potentiel de récupération fonctionnelle.

8.6 Réfraction

- Doit être réalisée ****sous cycloplégie**** (obligatoire chez l'enfant).
- Recherche d'hypermétropie (impliquée directement dans la genèse de l'ésotropie accommodative).
- La correction optique constitue souvent la ****première étape du traitement****.

9. Types de strabismes concomitants

9.1 Ésotropies

Ésotropie infantile

- Apparition ****avant 6 mois****.
- Angle de déviation important et constant ; alternance possible.
- Vision binoculaire absente ou très altérée.
- Signes associés fréquents : nystagmus latent, hyperaction des obliques inférieurs.
- Prise en charge : souvent chirurgicale après traitement de l'éventuelle amblyopie.

Ésotropie accommodative pure

- Liée à une ****hypermétropie non corrigée**** → accommodation excessive → convergence excessive.
- Apparaît généralement entre ****2 et 4 ans****.
- La déviation disparaît ****complètement**** avec la correction optique.
- Traitement : port permanent de lunettes.

Ésotropie partiellement accommodative

- La correction optique réduit l'angle mais ****ne l'élimine pas entièrement****.
- Prise en charge combinée : correction optique + traitement de l'amblyopie + chirurgie des muscles oculomoteurs si nécessaire.

9.2 Exotropies

Exotropie : définition

- Déviation des axes visuels ****vers l'extérieur****.
- Souvent intermittente au début, peut passer inaperçue initialement.
- La vision binoculaire est souvent partiellement conservée.
- Évolution possible vers une forme permanente sans prise en charge.

Exotropie intermittente (forme la plus fréquente)

- Déviation visible lors de : fatigue, inattention, fixation au loin, forte luminosité.
- Signes évocateurs : fermeture d'un œil en plein soleil, difficulté à maintenir la fixation.

- Prise en charge selon la fréquence et le retentissement : surveillance → rééducation → chirurgie.

9.3 Microstrabisme

- Déviation de faible amplitude (< 10 dioptries prismatiques).
- Passe souvent inaperçu à l'inspection simple.
- Fréquemment associé à une amblyopie modérée et une CRA.
- Vision binoculaire altérée mais partiellement conservée (fusion périphérique possible).
- Diagnostic : test de Lang, test de fixation excentrée.

9.4 Strabisme sensoriel

- Secondaire à une **baisse de vision unilatérale** (quelle qu'en soit la cause).
- La mauvaise qualité de l'image empêche le maintien de l'alignement.
- Peut être ésoptropie ou exotropie.
- Traitement : traiter la cause visuelle en priorité, puis corriger la déviation si nécessaire.

10. Traitement

10.1 Principes généraux

Les objectifs du traitement sont :

1. Obtenir un bon alignement oculaire.
2. Prévenir ou traiter l'amblyopie (**priorité urgente**).
3. Favoriser le développement ou la restauration de la vision binoculaire.

La prise en charge est souvent progressive, en collaboration étroite entre ophtalmologiste et orthoptiste.

10.2 Correction optique

- Première étape du traitement, surtout dans les ésootropies accommodatives.
- Port **constant** de lunettes prescrites après réfraction sous cycloplégie.
- Peut suffire à réaligner les axes visuels dans les formes purement accommodatives.

10.3 Traitement de l'amblyopie

- **Occlusion de l'œil dominant** pour stimuler l'œil amblyope.
- Alternatives : pénalisation optique ou pharmacologique.
- L'efficacité dépend de la **précocité** et de l'observance.

10.4 Rééducation orthoptique

- Objectif : améliorer les capacités de fusion et renforcer le contrôle de la déviation.
- Exercices de convergence, divergence et coordination binoculaire.
- Particulièrement utile dans les exotropies intermittentes et les troubles de la convergence.

10.5 Traitement chirurgical

- Indiqué en cas de déviation persistante malgré une prise en charge bien conduite.
- Techniques : recul (affaiblissement) ou résection (renforcement) des muscles oculomoteurs.
- Objectif : réaligner les axes visuels (amélioration fonctionnelle et esthétique).
- Ne dispense pas d'un suivi orthoptique post-opératoire.

11. Suivi

- Doit être ****régulier et prolongé****.
- Surveillance de l'évolution de la déviation, de l'efficacité du traitement et du développement de la vision binoculaire.
- Des ajustements thérapeutiques sont souvent nécessaires.

12. Cas cliniques

Cas 1 : Ésotropie accommodative avec amblyopie

- Enfant de 3 ans, déviation convergente constante apparue progressivement.
- Hypermétropie importante + amblyopie de l'œil droit.
- ****CAT**** : prescrire la correction optique adaptée + débiter le traitement de l'amblyopie. Réévaluation pour juger de la part accommodative.

Cas 2 : Exotropie intermittente

- Enfant avec exotropie visible en fin de journée et en vision de loin.
- Contrôle encore partiellement conservé.
- ****CAT**** : surveillance + rééducation orthoptique en première intention. Indication chirurgicale à discuter en cas d'aggravation ou de perte de contrôle.

13. Pièges diagnostiques à éviter

- ****Ne pas méconnaître un strabisme incomitant**** pouvant traduire une atteinte neurologique.
- ****Réfraction incomplète**** → erreur diagnostique (surtout dans les ésotropies

accommodatives).

- **Amblyopie** : doit être systématiquement recherchée car elle peut passer inaperçue.